DU FINDER DET OG VED, HVAD DU SKAL GØRE™

60 Behandlingsprotokoller Muskel for Muskel

Atlasset viser dig, hvor punktet er. Denne guide fortæller dig, hvad du gør ved det: lejring, teknik, udstrækning, dosering og hjemmeøvelser, muskel for muskel.

Indhold

1 · Generelle principper

2 · Hoved, ansigt og nakke

3 · Skulder, overarm, underarm og hånd

4 · Ryg, rygsøjle og truncus

5 · Bækken, hofte og balder

6 · Lår, underben og fod

Næste skridt

AFSNIT 1

Generelle principper

Hver protokol følger denne rækkefølge.

Hvem er det til

Undervisningsmateriale til fysioterapeuter, massører, osteopater, trænere og studerende inden for sundhedsfag. Protokollerne opsummerer teknikker, der ofte bruges i manuel behandling af myofasciale triggerpunkter. De erstatter ikke en lægefaglig diagnose eller din egen faglige vurdering.

TRIN	HVAD DU GØR	HVOR MEGET
1. Lokalisering	Find det stramme bånd og det mest ømme punkt i det (ifølge atlassets kort).	—
2. Iskæmisk kompression	Gradvist, stabilt tryk på punktet, indtil patienten angiver ubehag på ca. 5–7 på en skala fra 0–10. Når spændingen giver efter, følger du med dybere ned.	30–90 sek., 3–5 gentagelser
3. Udstrækning	Langsom og smertefri udstrækning af den muskel, du har behandlet, på udåndingen.	3 × 20–30 sek.
4. Aktiv bevægelse	Patienten bevæger musklen nogle gange gennem hele bevægeudslaget.	3–5 gentagelser
5. Hjemmeøvelse	Giv en enkel udstrækning eller øvelse (se slutningen af protokollen).	1–2 gange dagligt

Hvornår du IKKE behandler (og henviser til lægen)

Nylig skade eller hævelse, feber, natlige smerter uden kendt årsag, følelsesløshed eller svaghed, der ikke passer med kortet over refereret smerte, mistanke om trombose, hudlidelse i området. Hos en patient i blodfortyndende behandling bruger du kun let tryk.

AFSNIT 2

Hoved, ansigt og nakke

12 muskler i atlassets rækkefølge.

1. Trapezius – øvre fibre

Musculus trapezius, pars descendens

HVOR DU LEDER	Over skulderåget, midt mellem nakken og acromion, i den øvre frie kant.
REFERERET SMERTE	tindingen, siden af hovedet, siden af halsen, bag øret, underkæbens vinkel
PATIENT	Rygliggende eller siddende, armene afslappet på lårene.
TEKNIK	• Pincetgreb om de øvre fibre (tommel- og pegefinger), vedvarende iskæmisk kompression på det stramme bånd. • Alternativt: flad kompression med fingerspidserne over skulderåget.
UDSTRÆKNING	Hovedet lateralflekteres til modsat side med let fleksion; siddende holder patienten fast under stolen med hånden på samme side.
DOSERING	3–5 × 30–90 sek. kompression, derefter 3 × 20–30 sek. udstrækning.
HJEMME	Lateralfleksions-udstrækning to gange dagligt; skærmen i øjenhøjde; ingen mobiltelefon klemt mellem øre og skulder.

2. Sternocleidomastoideus (SCM)

Musculus sternocleidomastoideus

HVOR DU LEDER	Langs muskelbugen, især i den sternale og den klavikulære del; det mest ømme punkt ligger i den midterste tredjedel.
REFERERET SMERTE	panden, omkring øjet, kinden, dybt i øret, issen, baghovedet
PATIENT	Rygliggende, hovedet let lateralflekteret mod den behandlede side, så musklen slapper af.
TEKNIK	• Kun pincetgreb: tag fat om muskelbugen med to fingre og løft den forsigtigt væk fra de dybe strukturer i halsen. • Behandl den sternale og den klavikulære del hver for sig, nedefra og op.
UDSTRÆKNING	Hovedet lateralflekteres til modsat side, og derefter roteres hagen langsomt mod den behandlede side; let ekstension kun hvis det ikke giver svimmelhed.
DOSERING	3 × 30–60 sek. kompression med pincetgreb på hver del, derefter 2–3 × 20 sek. udstrækning.
HJEMME	Langsomme hovedbevægelser og -drejninger; ikke se fjernsyn liggende eller læse med hovedet løftet.

> **Pas på:** Arteria carotis løber lige under musklen: tryk aldrig bagud på forsiden af halsen. Ved svimmelhed, kvalme eller synsforstyrrelser stopper du straks.

3. Masseter

Musculus masseter

HVOR DU LEDER	I det overfladiske lag under arcus zygomaticus og over underkæbevinklen; i det dybe lag foran kæbeleddet.
REFERERET SMERTE	kindtænderne i over- og underkæben, underkæben, øjenbrynet, dybt i øret
PATIENT	Rygliggende, munden let åben.
TEKNIK	• Udvendigt: flad kompression med fingerspidserne under arcus zygomaticus og over kæbevinklen. • Intraoralt (med handske): pincetgreb med én finger i munden og én udenfor; langsom tværfriktion på fibrene.
UDSTRÆKNING	Langsom åbning af munden med tungespidsen mod ganen; terapeutens to fingre fører forsigtigt kæben nedad.
DOSERING	3 × 30–60 sek. kompression, 2–3 × 20 sek. udstrækning.
HJEMME	Daglig selvmassage med cirkulære bevægelser; undgå tyggegummi; vær opmærksom på, om tænderne bides sammen i løbet af dagen.

> **Pas på:** Ved nyopståede smerter i kæbeleddet eller problemer med tænderne skal en tandlæge undersøge først. I munden altid med handske.

4. Temporalis

Musculus temporalis

HVOR DU LEDER	Over arcus zygomaticus i fire zoner, forfra og bagud; let at palpere, når patienten tygger.
REFERERET SMERTE	tindingen, øjenbrynet, bag øjet, tænderne i overkæben, siden af hovedet
PATIENT	Rygliggende eller siddende, tænderne let adskilt.
TEKNIK	• Flad kompression med fingerspidserne på de fire fibergrupper over arcus zygomaticus, forfra og bagud. • Langsom tværfriktion på de stramme bånd.
UDSTRÆKNING	Langsom åbning af munden, mens terapeutens fingre glider opad over tindingen.
DOSERING	3 × 30–60 sek. på hvert punkt, derefter 3–5 langsomme stryg.
HJEMME	Selvmassage af tindingerne, når hovedpinen begynder; hold øje med natlig tænderskæren.

5. Pterygoideus lateralis

Musculus pterygoideus lateralis

HVOR DU LEDER	Dybt under arcus zygomaticus; intraoralt bag de øvre kindtænder, opad og bagud.
REFERERET SMERTE	kæbeleddet, kinden (over bihulerne)
PATIENT	Rygliggende, munden halvt åben.
TEKNIK	• Intraoralt, med handske: forsigtigt, langsomt tryk med lillefingeren bag de øvre kindtænder. • Udvendigt: kompression i fordybningen under arcus zygomaticus med åben mund.
UDSTRÆKNING	Langsom retraktion af underkæben (patienten trækker hagen let bagud) og derefter langsom lukning af munden.
DOSERING	2–3 × 20–30 sek. let tryk, 2 × 20 sek. udstrækning.
HJEMME	Undgå hårde og store mundfulde; åbn bevidst munden langsomt og lige.

> **Pas på:** I munden arbejder du kun med handske og meget blidt; ved smertefulde lyde eller hvis kæben «låser», henvis til tandlæge eller kæbekirurg.

6. Pterygoideus medialis

Musculus pterygoideus medialis

HVOR DU LEDER	På indersiden af underkæbevinklen, palperet nedefra; intraoralt bag den bageste kindtand.
REFERERET SMERTE	tungeroden, svælget, under øret, kæbeleddet
PATIENT	Rygliggende, hovedet let drejet mod den behandlede side.
TEKNIK	• Udvendigt: tryk med fingerspidserne opad på indersiden af kæbevinklen. • Intraoralt (med handske): forsigtigt tryk bag den bageste kindtand mod ganen.
UDSTRÆKNING	Langsom åbning af munden med kæben let forskudt mod modsat side.
DOSERING	2–3 × 20–30 sek. kompression, 2 × 20 sek. udstrækning.
HJEMME	Bevidst afspænding af sammenbidte tænder; blød kost på dage med smerter.

> **Pas på:** Ved smerter ved synkning eller ubehag i halsen skal der først en lægeundersøgelse til.

7. Splenius capitis

Musculus splenius capitis

HVOR DU LEDER	På den bageste sidedel af nakken, mellem SCM og trapezius, ca. 2–3 fingerbredder under protuberantia occipitalis externa.
REFERERET SMERTE	issen
PATIENT	Rygliggende eller maveliggende, hovedet i midtlinjen.
TEKNIK	• Flad kompression med fingerspidserne i trekanten mellem SCM og trapezius, opad og medialt. • Langsgående stryg mod nakkeknuden.
UDSTRÆKNING	Hovedet i fleksion og roteret mod modsat side.
DOSERING	3 × 30–60 sek. kompression, 3 × 20–30 sek. udstrækning.
HJEMME	Undgå at kigge opad i lang tid (maling, oprydning på hylder); pude i den rette højde.

8. Splenius cervicis

Musculus splenius cervicis

HVOR DU LEDER	Nederst i nakken, over skulderbladets øvre vinkel, ved siden af levator scapulae.
REFERERET SMERTE	bag øjet, baghovedet, overgangen mellem nakke og skulder
PATIENT	Maveliggende med støtte under panden.
TEKNIK	• Kompression med fingerspidserne ved nakkens basis, ved siden af columna. • Langsom tværfriktion på det stramme bånd.
UDSTRÆKNING	Hovedet i fleksion med lateralfleksion og rotation mod modsat side.
DOSERING	3 × 30–60 sek., derefter 3 × 20 sek. udstrækning.
HJEMME	Korrektion af fremskudt hovedholdning; bevægelsespause hver time.

9. Suboccipitale muskler

Mm. recti capitis posteriores et obliqui capitis

HVOR DU LEDER	Lige under nakkebenet, til højre og venstre for midtlinjen, i dybden.
REFERERET SMERTE	siden af hovedet, bag øjet, panden, baghovedet
PATIENT	Rygliggende, terapeuten sidder ved hovedenden af briksen.
TEKNIK	• Terapeutens fingerspidser under nakkeknuden; trykket kommer fra hovedets egen vægt (suboccipital release). • Vent, til vævet slipper, og fingrene langsomt synker ind.
UDSTRÆKNING	Hageretraktion (hovedet glider lige bagud) og derefter et let «nik» fremad.
DOSERING	1–2 × 60–120 sek. release, derefter 5–10 langsomme hageretraktioner.
HJEMME	10 hageretraktioner om dagen; skærmen i øjenhøjde; kort pause hver time.

> **Pas på:** Ved svimmelhed, synsforstyrrelser, følelsesløshed eller synkebesvær stopper du straks og henviser patienten til lægen.

10. Semispinalis capitis

Musculus semispinalis capitis

HVOR DU LEDER	I nakken, 2–3 cm fra midtlinjen, under nakkeknuden og midt på nakken.
REFERERET SMERTE	siden af hovedet, tindingen, panden, baghovedet
PATIENT	Maveliggende eller rygliggende med hovedet drejet til siden.
TEKNIK	• Kompression med fingerspidserne ved siden af columna, nedefra og op. • Langsgående stryg mod nakkeknuden.
UDSTRÆKNING	Hovedet i fleksion med let rotation til siden.
DOSERING	3 × 30–60 sek., derefter 3 × 20–30 sek. udstrækning.
HJEMME	Undgå fremskudt hovedholdning; hold bogen i øjenhøjde, når du læser.

11. Levator scapulae

Musculus levator scapulae

HVOR DU LEDER	Lidt medialt og over skulderbladets øvre vinkel; på siden af nakken, dybt under trapezius' øvre kant.
REFERERET SMERTE	overgangen mellem nakke og skulder, skulderbladets inderkant, bagsiden af skulderen
PATIENT	Maveliggende eller siddende, armene afslappet.
TEKNIK	• Kompression lidt medialt og over skulderbladets øvre vinkel. • Andet punkt: på siden af nakken, dybt under trapezius' øvre kant.
UDSTRÆKNING	Hovedet i fleksion og roteret mod modsat side (næsen mod armhulen), hånden på den behandlede side i nakken.
DOSERING	3–5 × 30–90 sek. kompression, 3 × 20–30 sek. udstrækning.
HJEMME	Samme udstrækning to gange dagligt; undgå høj pude og drejet hoved under arbejdet.

12. Scaleni

Mm. scaleni anterior, medius et posterior

HVOR DU LEDER	På siden af halsen, bag og under SCM, over kravebenet.
REFERERET SMERTE	forsiden af brystkassen, overarmen, skulderbladets inderkant, hånden (tommel- og pegefinger)
PATIENT	Rygliggende, hovedet let lateralflekteret mod den behandlede side.
TEKNIK	• Fladt, meget blidt tryk med fingerspidserne bag SCM's bageste kant, over kravebenet. • Korte greb på 20–30 sek.; patienten trækker vejret dybt ned i maven.
UDSTRÆKNING	Hovedet lateralflekteres til modsat side med let ekstension; terapeuten stabiliserer kravebenet på den behandlede side nedad.
DOSERING	3 × 20–30 sek. let tryk, 3 × 20 sek. udstrækning.
HJEMME	Træning af diafragmatisk vejrtrækning (mavevejrtrækning); ingen tung taske på skulderen.

> **Pas på:** Plexus brachialis og kar passerer gennem området: hvis der opstår følelsesløshed eller prikken, der breder sig ud i armen, så mindsk trykket eller stop. Ved vedvarende følelsesløshed: lægeundersøgelse.

AFSNIT 3

Skulder, overarm, underarm og hånd

14 muskler i atlassets rækkefølge.

13. Infraspinatus

Musculus infraspinatus

HVOR DU LEDER	På skulderbladets bagside, under spina scapulae, i den midterste og øvre del af fossa infraspinata.
REFERERET SMERTE	forsiden af skulderen (dybt), overarmens forreste yderside, underarmen, håndens tommelfingerside
PATIENT	Maveliggende eller sideliggende med den behandlede side opad.
TEKNIK	• Flad kompression med fingerspidserne eller tommelfingeren på skulderbladets bagside. • Arbejd dig punkt for punkt nedad fra spina scapulae.
UDSTRÆKNING	Armen på den behandlede side føres foran brystet, og den anden hånd trækker albuen ind mod brystet; eller hånden om på ryggen.
DOSERING	3–5 × 30–90 sek., derefter 3 × 20–30 sek. udstrækning.
HJEMME	Undgå at sove på den side, der gør ondt; i sideleje en pude under armen.

14. Supraspinatus

Musculus supraspinatus

HVOR DU LEDER	Over spina scapulae, i den mediale del af fossa supraspinata og lateralt under acromion.
REFERERET SMERTE	siden af skulderen (deltoidregionen), overarmens yderside, albuens yderside
PATIENT	Siddende eller maveliggende.
TEKNIK	• Dyb kompression med fingerspidserne over spina scapulae, gennem trapezius' fibre. • Lateralt, tæt på senen, kun let tryk.
UDSTRÆKNING	Armen på den behandlede side om på ryggen, den anden hånd trækker blidt håndleddet mod modsat side.
DOSERING	3 × 30–60 sek., 3 × 20–30 sek. udstrækning.
HJEMME	Undgå at løfte tunge ting over hovedhøjde; daglige skulderrotationer.

> **Pas på:** Skarp, jagende smerte i skulderen eller natlige smerter, der ikke går over: lægeundersøgelse for at udelukke en rotator cuff-skade.

15. Teres minor

Musculus teres minor

HVOR DU LEDER	Ved skulderbladets laterale kant, under infraspinatus, over den bageste aksillefold.
REFERERET SMERTE	bagsiden af skulderen (punktformet), overarmens bagside
PATIENT	Maveliggende eller sideliggende, med armen hængende ud over kanten af briksen.
TEKNIK	• Pincetgreb eller kompression med tommelfingeren ved skulderbladets laterale kant, over den bageste aksillefold.
UDSTRÆKNING	Armen føres foran brystet, albuen trækkes ind mod brystet.
DOSERING	3 × 30–60 sek., 3 × 20 sek. udstrækning.
HJEMME	Som ved infraspinatus; undgå at sove med armen over hovedet.

16. Subscapularis

Musculus subscapularis

HVOR DU LEDER	På skulderbladets forside; du når den fra armhulen, langs skulderbladets laterale kant.
REFERERET SMERTE	bagsiden af skulderen, skulderbladet, overarmens bagside, håndleddet
PATIENT	Rygliggende, armen abduceret ca. 45° og udadroteret.
TEKNIK	• Fra armhulen med fingerspidserne mod skulderbladets forside, meget langsomt. • Korte greb, efter patientens signal.
UDSTRÆKNING	Armen udadroteret, albuen i 90°, håndfladen føres blidt bagud (mod dørkarmen).
DOSERING	2–3 × 20–30 sek., 3 × 20 sek. udstrækning.
HJEMME	Øvelser i udadrotation; armen må ikke blive holdt tæt ind til kroppen i lang tid.

> **Pas på:** Kar og nerver passerer gennem armhulen: arbejd langsomt og blidt; hvis der opstår følelsesløshed, så mindsk trykket.

17. Deltoideus

Musculus deltoideus

HVOR DU LEDER	I de forreste, midterste og bageste fibre, 2–5 cm under acromion.
REFERERET SMERTE	skulderen (omkring punktet), overarmen
PATIENT	Siddende eller rygliggende.
TEKNIK	• Flad kompression eller pincetgreb på hver af de tre fibergrupper for sig. • Tværfriktion på de stramme bånd.
UDSTRÆKNING	Forreste fibre: armen bagud; bageste fibre: armen føres foran brystet.
DOSERING	3 × 30–60 sek. på hver fibergruppe, 2–3 × 20 sek. udstrækning.
HJEMME	Pauser ved gentagne løfteopgaver.

18. Pectoralis major

Musculus pectoralis major

HVOR DU LEDER	Ved brystmusklens laterale kant (forreste aksillefold), under kravebenet og ved siden af brystbenet.
REFERERET SMERTE	forsiden af brystkassen, forsiden af skulderen, overarmens inderside, brystregionen
PATIENT	Rygliggende, armen let abduceret.
TEKNIK	• Pincetgreb i den forreste aksillefold. • Flad kompression under kravebenet og ved siden af brystbenet.
UDSTRÆKNING	Udstrækning i døråbning: underarmen mod dørkarmen, albuen i skulderhøjde, kroppen tager langsomt et skridt frem.
DOSERING	3 × 30–90 sek., 3 × 20–30 sek. udstrækning.
HJEMME	Korrektion af foroverbøjet holdning; skuldrene tilbage og ned.

> **Pas på:** Ved smerter i venstre side af brystkassen, især ved anstrengelse, med åndenød eller sveden: udeluk først en hjerteårsag, straks til lægen.

19. Pectoralis minor

Musculus pectoralis minor

HVOR DU LEDER	Under processus coracoideus, over 3.–5. ribben, dybt under pectoralis major.
REFERERET SMERTE	forsiden af skulderen, brystkassen, overarmens inderside, håndens lillefingerside
PATIENT	Rygliggende, armene langs kroppen.
TEKNIK	• Fladt tryk med fingerspidserne under pectoralis major, fra armhulen medialt og opad. • Korte greb med langsom vejrtrækning.
UDSTRÆKNING	Skuldrene tilbage og ned; i dørkarmen er albuen over skulderhøjde.
DOSERING	3 × 20–30 sek., 3 × 20–30 sek. udstrækning.
HJEMME	Korrektion af fremskudt skulder; styrkelse af rygmusklerne.

> **Pas på:** Hvis der opstår følelsesløshed, der breder sig ud i armen, så mindsk trykket.

20. Rhomboidei

Mm. rhomboidei major et minor

HVOR DU LEDER	Mellem skulderbladets mediale kant og columna, under trapezius.
REFERERET SMERTE	skulderbladets inderkant, mellem skulderbladene
PATIENT	Maveliggende, armene afslappet langs briksen.
TEKNIK	• Kompression med tommelfingeren langs skulderbladets mediale kant, oppefra og ned. • Tværfriktion på fibrene.
UDSTRÆKNING	Armene krydses foran kroppen (kram dig selv), ryggen krummes let.
DOSERING	3 × 30–60 sek., 3 × 20–30 sek. udstrækning.
HJEMME	Udstrækning af brystmusklen (rhomboideerne er ofte forlængede og svage).

21. Serratus anterior

Musculus serratus anterior

HVOR DU LEDER	På siden af brystkassen, under armhulen, i højde med 5.–6. ribben.
REFERERET SMERTE	siden af brystkassen, skulderbladets nederste vinkel, overarmens inderside
PATIENT	Sideliggende med den behandlede side opad, armen foran.
TEKNIK	• Fladt tryk med fingerspidserne under armhulen, mellem ribbenene. • Langsomme stryg langs ribbenene.
UDSTRÆKNING	Armen bagud og skulderbladet trukket ind mod columna; med en dyb indånding.
DOSERING	3 × 20–30 sek., 3 × 20 sek. udstrækning.
HJEMME	Ofte efter hoste og intensivt løb: gradvis øgning af belastningen.

> **Pas på:** Ved akutte sidesmerter, der hænger sammen med vejrtrækningen, feber eller hoste: først lægeundersøgelse.

22. Latissimus dorsi

Musculus latissimus dorsi

HVOR DU LEDER	I den bageste aksillefold, i højde med skulderbladets nedre vinkel.
REFERERET SMERTE	skulderbladets nederste vinkel, overarmens bageste inderside, ring- og lillefinger
PATIENT	Maveliggende eller sideliggende, armen løftet over hovedet.
TEKNIK	• Pincetgreb i den bageste aksillefold. • Flad kompression ved siden af skulderbladets nedre vinkel.
UDSTRÆKNING	Armen over hovedet, kroppen lateralflekteret mod modsat side.
DOSERING	3 × 30–60 sek., 3 × 20–30 sek. udstrækning.
HJEMME	Udstrækning efter pull-ups og trækøvelser.

23. Biceps brachii

Musculus biceps brachii

HVOR DU LEDER	I den midterste tredjedel af overarmens forside, i begge hoveder.
REFERERET SMERTE	forsiden af skulderen, albuebøjningen
PATIENT	Rygliggende, albuen let bøjet.
TEKNIK	• Pincetgreb om muskelbugen. • Flad kompression i den midterste tredjedel.
UDSTRÆKNING	Albuen strakt, underarmen proneret, armen bagud.
DOSERING	3 × 30–60 sek., 3 × 20 sek. udstrækning.
HJEMME	Undgå at bære tunge ting med bøjet albue.

24. Triceps brachii

Musculus triceps brachii

HVOR DU LEDER	På bagsiden af overarmen, i det lange hoved under armhulen og 4–6 cm over albuen.
REFERERET SMERTE	bagsiden af skulderen, albuens yderside, underarmens bagside
PATIENT	Maveliggende med armen hængende eller rygliggende med armen over hovedet.
TEKNIK	• Pincetgreb om det lange hoved. • Flad kompression over albuen.
UDSTRÆKNING	Armen over hovedet, albuen helt bøjet, den anden hånd skubber den blidt bagud.
DOSERING	3 × 30–60 sek., 3 × 20 sek. udstrækning.
HJEMME	Pauser ved gang med krykker og ved armbøjninger.

25. Underarmens ekstensorer (ECRL, ECRB, extensor digitorum)

Mm. extensores carpi radiales et extensor digitorum

HVOR DU LEDER	På underarmens bageste laterale side, 3–6 cm under albuen.
REFERERET SMERTE	albuens yderside, underarmens bagside, håndryggen, fingrene
PATIENT	Siddende, underarmen på bordet, håndfladen nedad.
TEKNIK	• Kompression med tommelfingeren på muskelbugene under albuen. • Tværfriktion på muskelbugen (ikke på knoglefæstet).
UDSTRÆKNING	Albuen strakt, håndled og fingre flekteret, den anden hånd trækker blidt nedad.
DOSERING	3 × 30–60 sek., 3 × 20–30 sek. udstrækning.
HJEMME	Pauser ved brug af mus og ved skruearbejde; løsn grebet.

> **Pas på:** Ved hævelse, lokal varme eller natlig følelsesløshed: først lægeundersøgelse.

26. Underarmens fleksorer

Mm. flexores carpi et digitorum

HVOR DU LEDER	På underarmens forreste mediale side, 3–6 cm under albuen.
REFERERET SMERTE	håndleddets håndfladeside, håndfladen, fingrenes håndfladeside
PATIENT	Siddende, underarmen på bordet, håndfladen opad.
TEKNIK	• Kompression med tommelfingeren på muskelbugene. • Langsgående stryg mod håndleddet.
UDSTRÆKNING	Albuen strakt, håndfladen opad, fingrene trukket bagud.
DOSERING	3 × 30–60 sek., 3 × 20–30 sek. udstrækning.
HJEMME	Pauser ved manuelt arbejde (havearbejde, montage); løsn grebet.

Pas på: Ved natlig følelsesløshed, der breder sig ud i fingrene (fx karpaltunnelsyndrom): lægeundersøgelse.

AFSNIT 4

Ryg, rygsøjle og truncus

10 muskler i atlassets rækkefølge.

27. Trapezius – midterste fibre

Musculus trapezius, pars transversa

HVOR DU LEDER	Mellem scapulas mediale rand og rygsøjlen, i højde med spina scapulae, overfladisk.
REFERERET SMERTE	mellem skulderbladene, brænden ved siden af rygsøjlen
PATIENT	Maveleje, armene langs briksen.
TEKNIK	• Flad kompression med tommelfingeren langs scapulas mediale rand. • Tværfriktion på fibrene.
UDSTRÆKNING	Armene krydses foran kroppen, ryggen krummes.
DOSERING	3 × 30–60 sek., 3 × 20–30 sek. udstrækning.
HJEMME	Korrektion af den foroverbøjede siddestilling; udstrækning af pectoralis.

28. Trapezius – nedre fibre

Musculus trapezius, pars ascendens

HVOR DU LEDER	Mellem scapulas angulus inferior og rygsøjlen, midt på ryggen.
REFERERET SMERTE	nakken, acromion, mellem skulderbladene
PATIENT	Maveleje.
TEKNIK	• Pincetgreb eller kompression med tommelfingeren ved scapulas angulus inferior, medialt.
UDSTRÆKNING	Armene frem og op, ryggen krummet.
DOSERING	3 × 30–60 sek., 3 × 20 sek. udstrækning.
HJEMME	Styrkelse: armløft i Y-form fra maveleje.

29. Serratus posterior superior

Musculus serratus posterior superior

HVOR DU LEDER	Under den øvre del af scapula, ved siden af rygsøjlen; du når den, når scapula trækkes ud til siden.
REFERERET SMERTE	dybt under skulderbladet, bagsiden af skulderen, overarmens bagside, lillefingeren
PATIENT	Siddende, armen på den behandlede side krydset foran kroppen, så scapula åbnes.
TEKNIK	• Flad kompression med fingerspidserne på ribbenet under scapulas øvre mediale rand. • Korte greb med rolig vejrtrækning.
UDSTRÆKNING	Armen krydset foran kroppen, ryggen krummet.
DOSERING	2–3 × 20–30 sek., 3 × 20 sek. udstrækning.
HJEMME	Abdominal vejrtrækning i stedet for overfladisk (hurtig) brystvejrtrækning.

30. Iliocostalis thoracis

Musculus iliocostalis thoracis

HVOR DU LEDER	Ca. 5–8 cm fra rygsøjlen, i den midterste og nederste thorakalcolumna.
REFERERET SMERTE	midt på ryggen, maven (nogle gange), under skulderbladet
PATIENT	Maveleje, en lille pude under maven.
TEKNIK	• Kompression med tommelfingeren på den laterale rand af erector spinae. • Langsgående strygninger nedad.
UDSTRÆKNING	Fremadbøjning fra siddende, med overkroppen let roteret mod modsatte side.
DOSERING	3 × 30–60 sek., 3 × 20–30 sek. udstrækning.
HJEMME	Bevægelsespauser ved langvarigt stillesiddende arbejde.

> **Pas på:** Ved rygsmerter sammen med mavesmerter, feber eller vandladningsgener: først lægeundersøgelse.

31. Iliocostalis lumborum

Musculus iliocostalis lumborum

HVOR DU LEDER	I lænden, ca. 5–7 cm fra rygsøjlen, under de nederste ribben.
REFERERET SMERTE	lænden, glutealregionen, nederste del af maven
PATIENT	Maveleje, pude under maven.
TEKNIK	• Kompression med tommelfingeren eller albuen på den laterale rand af erector spinae.
UDSTRÆKNING	Rygleje med knæene trukket op mod brystet.
DOSERING	3–5 × 30–90 sek., 3 × 20–30 sek. udstrækning.
HJEMME	Løft med bøjede knæ og lige ryg; afbryd langvarigt stillesiddende arbejde.

> **Pas på:** Følelsesløshed eller svaghed, der breder sig ned i benet, eller forstyrrelser af vandladning eller afføring: straks til lægen.

32. Longissimus thoracis

Musculus longissimus thoracis

HVOR DU LEDER	2–4 cm fra rygsøjlen, i den nederste thorakal- og øverste lændecolumna.
REFERERET SMERTE	glutealregionen, lænden, hoftekammen (crista iliaca)
PATIENT	Maveleje.
TEKNIK	• Kompression med tommelfingeren langs rygsøjlen, nedefra og op.
UDSTRÆKNING	Fremadbøjning fra siddende eller rygleje med knæene mod brystet.
DOSERING	3 × 30–60 sek., 3 × 20–30 sek. udstrækning.
HJEMME	Afbryd kontorarbejdet hver time.

> **Pas på:** Ved følelsesløshed eller svaghed, der breder sig ned i benet: lægeundersøgelse.

33. Multifidus

Musculus multifidus

HVOR DU LEDER	Lige ved siden af processus spinosi, i dybden, i alle dele af rygsøjlen (oftest i lænden).
REFERERET SMERTE	punktformet ved siden af rygsøjlen, korsbenet, maven (sjældent)
PATIENT	Maveleje, pude under maven.
TEKNIK	• Dyb og langsom kompression med tommelfingeren ved siden af processus spinosus, skråt rettet medialt.
UDSTRÆKNING	Rygleje med knæene mod brystet og let rotation til siden.
DOSERING	3 × 30–60 sek., 3 × 20–30 sek. udstrækning.
HJEMME	Aktivering af det dybe stabiliserende system (træk maven let ind uden at spænde mavemusklerne).

34. Quadratus lumborum

Musculus quadratus lumborum

HVOR DU LEDER	Mellem det nederste ribben og crista iliaca, ved den laterale rand af erector spinae, i dybden.
REFERERET SMERTE	hoftekammen (crista iliaca), glutealregionen, siden af hoften, lænden
PATIENT	Sideleje med den behandlede side opad, det øverste ben hængende bagud (rummet mellem bækken og ribben åbnes).
TEKNIK	• Kompression med tommelfingeren ved randen af erector spinae, medialt mod rygsøjlen. • To punkter: under det nederste ribben og over hoftebenet.
UDSTRÆKNING	Sidebøjning stående eller i sideleje, med den øverste arm over hovedet.
DOSERING	3–5 × 30–90 sek., 3 × 20–30 sek. udstrækning.
HJEMME	Undgå at stå på ét ben og at bære tasken kun i den ene side.

Pas på: Smerter i nyreregionen sammen med feber eller vandladningsgener: først lægeundersøgelse.

35. Rectus abdominis

Musculus rectus abdominis

HVOR DU LEDER	Over og under navlen, 2–4 cm fra midtlinjen.
REFERERET SMERTE	vandret bånd midt på ryggen, maven, lænden
PATIENT	Rygleje, pude under knæene.
TEKNIK	• Pincetgreb eller flad kompression ved muskelranden.
UDSTRÆKNING	Rygleje med en pude under lænden, armene over hovedet.
DOSERING	3 × 20–30 sek., 3 × 20 sek. udstrækning.
HJEMME	Udstrækning efter overdreven mavetræning.

Pas på: Mavesmerter med feber, opkast eller ændringer i afføring eller urin: lægeundersøgelse, ingen behandling.

36. Obliquus externus abdominis

Musculus obliquus externus abdominis

HVOR DU LEDER	På siden af maven, under kurvaturen og over crista iliaca.
REFERERET SMERTE	siden af maven, lænden, nederste del af brystkassen
PATIENT	Rygleje eller sideleje.
TEKNIK	• Flad kompression med fingerspidserne under kurvaturen. • Pincetgreb på siden af maven.
UDSTRÆKNING	Rygleje med knæene faldende mod modsatte side, skuldrene i underlaget.
DOSERING	3 × 20–30 sek., 3 × 20 sek. udstrækning.
HJEMME	Gradvis øgning af belastningen i rotationsbevægelser.

> **Pas på:** Ved mavegener udelukkes først årsager fra de indre organer.

AFSNIT 5

Bækken, hofte og balder

10 muskler i atlassets rækkefølge.

37. Gluteus maximus

Musculus gluteus maximus

HVOR DU LEDER	I den nederste mediale del af glutealregionen, ved siden af os sacrum og over tuber ischiadicum.
REFERERET SMERTE	glutealregionen, korsbenet, omkring halebenet
PATIENT	Maveleje eller sideleje.
TEKNIK	• Kompression med albuen eller tommelfingeren ved siden af os sacrum og over tuber ischiadicum.
UDSTRÆKNING	Rygleje, knæet trækkes mod den modsatte skulder.
DOSERING	3–5 × 30–90 sek., 3 × 20–30 sek. udstrækning.
HJEMME	Afbryd langvarig siddende stilling; en lille pude på en hård stol.

38. Gluteus medius

Musculus gluteus medius

HVOR DU LEDER	2–5 cm under crista iliaca, i den øverste laterale del af glutealregionen.
REFERERET SMERTE	nederste del af lænden, korsbenet, siden af hoften, glutealregionen
PATIENT	Sideleje med den behandlede side opad.
TEKNIK	• Kompression med tommelfingeren under crista iliaca, forfra og bagud.
UDSTRÆKNING	I sideleje hænger det øverste ben ud over kanten af briksen bag kroppen; eller stående med krydsede ben, sidebøjning.
DOSERING	3–5 × 30–90 sek., 3 × 20–30 sek. udstrækning.
HJEMME	Undgå at stå på ét ben og at sidde med krydsede ben; styrkelse af hoftens abduktorer.

39. Gluteus minimus

Musculus gluteus minimus

HVOR DU LEDER	Dybt under gluteus medius, mellem crista iliaca og trochanter major.
REFERERET SMERTE	lårets yderside, underbenets yderside, bagsiden af låret, anklen
PATIENT	Sideleje med den behandlede side opad, det øverste knæ understøttet.
TEKNIK	• Dyb, langsom kompression med tommelfingeren eller albuen over og foran trochanter major.
UDSTRÆKNING	Rygleje, benet krydser over mod den modsatte side.
DOSERING	3–5 × 30–90 sek., 3 × 20–30 sek. udstrækning.
HJEMME	Afbryd lange bilture og langvarig siddende stilling.

Pas på: Smerteudbredelsen minder om iskias: ved følelsesløshed, svaghed eller ændrede reflekser bør en lægeundersøgelse udelukke en årsag fra en nerverod.

40. Piriformis

Musculus piriformis

HVOR DU LEDER	I den midterste og laterale tredjedel af linjen mellem os sacrums laterale rand og spidsen af trochanter major.
REFERERET SMERTE	glutealregionen, korsbenet, bagsiden af låret, bag hofteleddet
PATIENT	Maveleje eller sideleje med det øverste knæ bøjet.
TEKNIK	• Dyb kompression med tommelfingeren eller albuen på linjen mellem os sacrum og trochanter major.
UDSTRÆKNING	Rygleje, anklen fra det behandlede ben på det andet knæ, det andet lår trukket mod brystet («4-tals»-udstrækning).
DOSERING	3–5 × 30–90 sek., 3 × 20–30 sek. udstrækning.
HJEMME	Undgå at sidde på pungen; undgå at sidde med krydsede ben.

Pas på: Nervus ischiadicus løber tæt forbi: hvis der opstår følelsesløshed, så mindsk trykket; ved vedvarende følelsesløshed i benet: læge.

41. Iliopsoas

Musculus iliopsoas

HVOR DU LEDER	På forsiden af låret under ligamentum inguinale (lateralt for arteria femoralis) og i maven, på indersiden af hoftebenet.
REFERERET SMERTE	lænden ved siden af rygsøjlen, korsbenet, forsiden af låret
PATIENT	Rygleje, knæene bøjet, så bugvæggen afspændes.
TEKNIK	• Under udånding: langsomt fladt tryk med fingerspidserne fra maven mod indersiden af hoftebenet. • På låret: under ligamentum inguinale, lateralt for arterien.
UDSTRÆKNING	Udfaldsstilling (lunge): det bageste knæ i gulvet, bækkenet skubbes frem.
DOSERING	2–3 × 20–30 sek., 3 × 20–30 sek. udstrækning.
HJEMME	Udstrækning i udfaldsstilling efter langvarig siddende stilling.

> **Pas på:** Arterien løber tæt forbi (den pulserer): tryk aldrig på den. Ved mavegener og under graviditet må den abdominale del ikke behandles.

42. Tensor fasciae latae

Musculus tensor fasciae latae

HVOR DU LEDER	På den anterolaterale side af hoften, under spina iliaca anterior superior.
REFERERET SMERTE	lårets yderside, knæets yderside
PATIENT	Rygleje eller sideleje.
TEKNIK	• Kompression med tommelfingeren under og lateralt for hoftebenets forreste fremspring.
UDSTRÆKNING	I sideleje er det øverste ben strakt og hænger bagud og nedad.
DOSERING	3 × 30–60 sek., 3 × 20–30 sek. udstrækning.
HJEMME	Undgå for kraftig hoftefleksion, når du sidder.

43. Adductor longus og brevis

Musculus adductor longus

HVOR DU LEDER	På indersiden af låret, i den øverste tredjedel.
REFERERET SMERTE	lysken, lårets inderside, knæets inderside
PATIENT	Rygleje, knæet bøjet og faldet ud til siden.
TEKNIK	• Pincetgreb om muskelbugen. • Flad kompression på indersiden af låret.
UDSTRÆKNING	Siddende med fodsålerne samlet (sommerfugl), knæene falder nedad.
DOSERING	3 × 30–60 sek., 3 × 20–30 sek. udstrækning.
HJEMME	Opvarmning før hurtige sidelæns bevægelser.

44. Adductor magnus

Musculus adductor magnus

HVOR DU LEDER	På den posteromediale side af låret, i den midterste tredjedel og tæt ved tuber ischiadicum.
REFERERET SMERTE	lysken, lårets inderside, dybt i bækkenet
PATIENT	Rygleje med knæet bøjet og faldet ud til siden, eller sideleje.
TEKNIK	• Flad kompression på den posteromediale side af låret.
UDSTRÆKNING	Siddende med spredte ben, fremadbøjning.
DOSERING	3 × 30–60 sek., 3 × 20–30 sek. udstrækning.
HJEMME	Gradvis øgning af belastningen, opvarmning.

> **Pas på:** Ved gener i det lille bækken eller gynækologiske gener: først lægeundersøgelse.

45. Pectineus

Musculus pectineus

HVOR DU LEDER	På den anteromediale side af låret, under lyskefolden, medialt for arteria femoralis.
REFERERET SMERTE	dybt i lysken, lårets forreste inderside
PATIENT	Rygleje, benet i let abduktion og udadrotation.
TEKNIK	• Langsomt fladt tryk med fingerspidserne under lyskefolden, medialt for arterien.
UDSTRÆKNING	Benet i abduktion og strakt, let bagud.
DOSERING	2–3 × 20–30 sek., 3 × 20 sek. udstrækning.
HJEMME	Undgå at presse lårene sammen, når du sidder.

> **Pas på:** Arterie, vene og lymfeknuder i lysken ligger tæt ved: arbejd blidt og tryk aldrig på et område, der pulserer.

46. Sartorius

Musculus sartorius

HVOR DU LEDER	Skråt over forsiden af låret, fra hoftebenets forreste fremspring til indersiden af knæet, overfladisk.
REFERERET SMERTE	forsiden af låret (brændende, stikkende fornemmelse), knæets inderside
PATIENT	Rygleje.
TEKNIK	• Pincetgreb om det smalle muskelbånd, oppefra og ned.
UDSTRÆKNING	Hoften i ekstension med let indadrotation (udfaldsstilling).
DOSERING	3 × 20–30 sek., 3 × 20 sek. udstrækning.
HJEMME	Undgå langvarig siddende stilling med benene over kors på gulvet.

AFSNIT 6

Lår, underben og fod

14 muskler i atlassets rækkefølge.

47. Rectus femoris

Musculus rectus femoris

HVOR DU LEDER	På forsiden af låret, lige under hoften, tæt ved spina iliaca anterior inferior.
REFERERET SMERTE	forsiden af knæet, omkring knæskallen
PATIENT	Rygleje.
TEKNIK	• Flad kompression eller pincetgreb på den øverste forreste del af låret.
UDSTRÆKNING	Maveleje eller stående, hælen trækkes mod ballen, hoften i ekstension.
DOSERING	3 × 30–60 sek., 3 × 20–30 sek. udstrækning.
HJEMME	Gradvis øgning af belastningen på trapper og i squat.

48. Vastus medialis

Musculus vastus medialis

HVOR DU LEDER	På den anteromediale side af låret, 5–10 cm over knæet.
REFERERET SMERTE	knæets inderside, forsiden af knæet
PATIENT	Rygleje, en lille pude under knæet.
TEKNIK	• Flad kompression med tommelfingeren over knæet, på den mediale side.
UDSTRÆKNING	Knæet maksimalt bøjet (hælen mod ballen).
DOSERING	3 × 30–60 sek., 3 × 20 sek. udstrækning.
HJEMME	Styrkelse: stræk knæet fra siddende og hold.

49. Vastus lateralis

Musculus vastus lateralis

HVOR DU LEDER	På ydersiden af låret, flere steder mellem hofte og knæ.
REFERERET SMERTE	lårets yderside, knæets yderside, bag knæskallen
PATIENT	Sideleje med den behandlede side opad.
TEKNIK	• Kompression med albuen eller tommelfingeren på ydersiden af låret, nedefra og op.
UDSTRÆKNING	Knæet maksimalt bøjet, benet i let indadrotation.
DOSERING	3–5 × 30–90 sek., 3 × 20–30 sek. udstrækning.
HJEMME	Undgå at ligge på siden på den ømme side.

50. Biceps femoris

Musculus biceps femoris

HVOR DU LEDER	På den posterolaterale side af låret, i den midterste og nederste tredjedel.
REFERERET SMERTE	knæhasen, bagsiden af låret
PATIENT	Maveleje, pude under anklen.
TEKNIK	• Pincetgreb eller kompression med tommelfingeren på den posterolaterale side af låret.
UDSTRÆKNING	Rygleje, løft af det strakte ben med anklen i dorsalfleksion.
DOSERING	3 × 30–60 sek., 3 × 20–30 sek. udstrækning.
HJEMME	Ved langvarig siddende stilling må stolekanten ikke trykke på låret.

51. Semitendinosus og semimembranosus

Mm. semitendinosus et semimembranosus

HVOR DU LEDER	På den posteromediale side af låret, i den midterste og nederste tredjedel.
REFERERET SMERTE	nederste del af glutealregionen, bagsiden af låret, indersiden af knæhasen
PATIENT	Maveleje.
TEKNIK	• Pincetgreb på den posteromediale side af låret.
UDSTRÆKNING	Rygleje, løft af det strakte ben, let ud til siden.
DOSERING	3 × 30–60 sek., 3 × 20–30 sek. udstrækning.
HJEMME	Opvarmning før løb.

52. Gastrocnemius

Musculus gastrocnemius

HVOR DU LEDER	I den øverste del af læggen, på det mediale og laterale hoved, under knæhasen.
REFERERET SMERTE	fodens svang, læggen, knæhasen
PATIENT	Maveleje, pude under anklen.
TEKNIK	• Pincetgreb eller kompression med tommelfingeren på begge hoveder.
UDSTRÆKNING	Stående foran en væg, det bageste ben strakt, hælen i gulvet.
DOSERING	3–5 × 30–90 sek., 3 × 20–30 sek. udstrækning.
HJEMME	Ved natlige kramper: udstrækning om aftenen; tilstrækkeligt væskeindtag.

> **Pas på:** Ensidig hævelse, lokal varme eller rødme i læggen (mistanke om trombose): ingen massage, straks til lægen.

53. Soleus

Musculus soleus

HVOR DU LEDER	I den nederste del af læggen, dybt under gastrocnemius, over achillessenen.
REFERERET SMERTE	hælen, læggen, korsbenet (sjældent)
PATIENT	Maveleje, knæet bøjet 90°.
TEKNIK	• Flad kompression fra begge sider i den nederste del af læggen.
UDSTRÆKNING	Stående foran en væg, det bageste knæ let bøjet, hælen i gulvet.
DOSERING	3–5 × 30–90 sek., 3 × 20–30 sek. udstrækning.
HJEMME	Undgå sko med høje hæle.

> **Pas på:** Ved ensidig hævelse eller lokal varme i læggen: ingen behandling, til lægen for at udelukke trombose.

54. Tibialis anterior

Musculus tibialis anterior

HVOR DU LEDER	Lige lateralt for skinnebenet, i den øverste tredjedel af underbenet.
REFERERET SMERTE	forsiden af anklen, storetåen
PATIENT	Rygleje.
TEKNIK	• Kompression med tommelfingeren på muskelbugen, ved siden af skinnebenet.
UDSTRÆKNING	Ankel og tæer i plantarfleksion (siddende med fodryggen nedad).
DOSERING	3 × 30–60 sek., 3 × 20–30 sek. udstrækning.
HJEMME	Gradvis øgning af løbebelastningen; mindre løb på hårdt underlag.

> **Pas på:** Ved kraftige smerter på skinnebenet, der tiltager med belastning (mistanke om træthedsbrud): lægeundersøgelse.

55. Peroneus (fibularis) longus

Musculus fibularis longus

HVOR DU LEDER	På ydersiden af underbenet, i den øverste tredjedel, 2–4 cm under caput fibulae.
REFERERET SMERTE	den udvendige ankelknogle (lateral malleol), fodens yderside
PATIENT	Sideleje med den behandlede side opad.
TEKNIK	• Kompression med tommelfingeren på ydersiden af underbenet.
UDSTRÆKNING	Foden drejet indad og i plantarfleksion.
DOSERING	3 × 30–60 sek., 3 × 20 sek. udstrækning.
HJEMME	Stabiliseringsøvelser for anklen på ét ben.

Pas på: Nervus peroneus løber bag caput fibulae: tryk ikke der.

56. Tibialis posterior

Musculus tibialis posterior

HVOR DU LEDER	Dybt i læggen, bag skinnebenets posteromediale rand.
REFERERET SMERTE	akillessenen, hælen, fodsålen
PATIENT	Maveleje, knæet bøjet.
TEKNIK	• Dyb, langsom kompression bag skinnebenets posteromediale rand.
UDSTRÆKNING	Foden drejet udad og i dorsalfleksion.
DOSERING	2–3 × 30–60 sek., 3 × 20 sek. udstrækning.
HJEMME	Passende støtte af fodbuen; ved platfod: specialist.

57. Extensor digitorum longus

Musculus extensor digitorum longus

HVOR DU LEDER	På den anterolaterale side af underbenet, lateralt for tibialis anterior, i den øverste tredjedel.
REFERERET SMERTE	fodryggen, de midterste tæer
PATIENT	Rygleje.
TEKNIK	• Kompression med tommelfingeren på den anterolaterale side af underbenet.
UDSTRÆKNING	Tæer og ankel i plantarfleksion.
DOSERING	3 × 30–60 sek., 3 × 20 sek. udstrækning.
HJEMME	Undgå stramme sko.

58. Flexor digitorum brevis

Musculus flexor digitorum brevis

HVOR DU LEDER	Midt under fodsålen, foran hælen.
REFERERET SMERTE	midt på fodsålen, roden af tæerne
PATIENT	Maveleje, foden ud over kanten af briksen.
TEKNIK	• Kompression med tommelfingeren midt under fodsålen. • Langsomme strygninger med en lille bold eller med en fingerknoge.
UDSTRÆKNING	Tæerne trukket opad, anklen i dorsalfleksion.
DOSERING	3 × 30–60 sek., 3 × 20 sek. udstrækning.
HJEMME	Passende fodtøj; massage af fodsålen med en lille bold.

Pas på: Ved skarpe smerter i hælen ved de første skridt om morgenen (plantar fasciitis): læge eller specialist.

59. Abductor hallucis

Musculus abductor hallucis

HVOR DU LEDER	Ved fodsålens mediale rand, mellem hælen og storetåens basis.
REFERERET SMERTE	hælens inderside, svangens inderkant
PATIENT	Sideleje med indersiden af den behandlede fod opad.
TEKNIK	• Kompression med tommelfingeren ved fodsålens mediale rand.
UDSTRÆKNING	Storetåen trukket indad (mod de andre tæer), anklen i dorsalfleksion.
DOSERING	3 × 30–60 sek., 3 × 20 sek. udstrækning.
HJEMME	Sko med bredere tåboks; styrkelse af storetåen.

60. Quadratus plantae

Musculus quadratus plantae

HVOR DU LEDER	I den bageste del af fodsålen, i dybden, lige foran hælen.
REFERERET SMERTE	hælens underside
PATIENT	Maveleje, foden ud over kanten af briksen.
TEKNIK	• Dyb, langsom kompression med tommelfingeren foran hælen.
UDSTRÆKNING	Tær og ankel i dorsalfleksion.
DOSERING	2–3 × 30–60 sek., 3 × 20 sek. udstrækning.
HJEMME	Massage af fodsålen med en lille bold, behagelige sko.

Pas på: Ved hævelse, følelsesløshed eller natlige smerter i hælen: lægeundersøgelse.

Næste skridt

I dag: læs de generelle principper. **I morgen:** følg protokollen for trapezius og levator scapulae hos din næste patient med nakke- eller skuldersmerter, og notér, hvad du fandt.